

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PULPECTOMÍA

HISTORIA CLÍNICA N.º: _____ FECHA: ____ / ____ / ____

DATOS DEL PACIENTE

Nombre _____ completo: Documento _____ de _____ identidad: _____

Edad: _____ Teléfono: _____

ODONTÓLOGO TRATANTE

Nombre: _____ Registro _____ profesional: _____

DIENTE A TRATAR

Arcada: ☐ Superior ☐ Inferior Cuadrante: _____

Diente: _____ Diagnóstico _____ pulpar: _____

Diagnóstico periapical: _____ Hallazgos _____ radiográficos: _____

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO AUTORIZADO

Yo, _____, identificado(a) con documento de identidad N.º _____, declaro que he recibido información clara, suficiente y comprensible acerca del procedimiento de pulpectomía que será realizado en el diente anteriormente descrito.

Comprendo que la pulpectomía consiste en la remoción parcial o total del tejido pulpar inflamado, infectado o necrótico contenido en la cámara pulpar y conductos radiculares, con el objetivo de controlar el dolor, disminuir la carga bacteriana, detener el proceso inflamatorio o infeccioso y preservar temporalmente el órgano dental.

Entiendo que este procedimiento puede realizarse como tratamiento de urgencia o como fase inicial de un tratamiento endodóntico definitivo.

Comprendo que la pulpectomía por sí sola no garantiza la resolución definitiva del problema y que generalmente será necesario completar posteriormente el tratamiento de conductos.

PROTOCOLO CLÍNICO DEL PROCEDIMIENTO

Se me ha explicado que el tratamiento podrá incluir una o varias de las siguientes fases:

■ Evaluación clínica.	■ Instrumentación inicial de conductos radiculares.
■ Evaluación radiográfica.	■ Irrigación química con soluciones desinfectantes.
■ Pruebas de sensibilidad pulpar.	■ Control de hemorragia cuando corresponda.
■ Diagnóstico pulpar y periapical.	■ Colocación de medicación intracanal.
■ Aplicación de anestesia local.	■ Sellado provisional del acceso endodóntico.
■ Aislamiento absoluto mediante dique de goma cuando sea posible.	■ Controles clínicos y radiográficos posteriores.
■ Apertura cameral.	■ Programación de tratamiento endodóntico definitivo.
■ Eliminación de tejido pulpar inflamado o necrótico.	

BENEFICIOS DEL PROCEDIMIENTO

Comprendo que los beneficios esperados incluyen:

- Disminución o eliminación del dolor.
- Control inicial de la infección.
- Disminución de la inflamación pulpar.
- Conservación temporal del diente.
- Preparación para tratamiento endodóntico definitivo.
- Reducción del riesgo de propagación de la infección.
- Mejoría de la función oral.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

Comprendo que la pulpectomía es frecuentemente una fase inicial del tratamiento y que por sí sola puede no resolver completamente la enfermedad pulpar o periapical.

Entiendo que el éxito del procedimiento depende de:

- Estado biológico del diente.
- Extensión de la infección.
- Complejidad anatómica de los conductos.
- Calidad del sellado provisional.
- Cumplimiento de controles posteriores.
- Realización oportuna del tratamiento definitivo.

Comprendo que no existen garantías absolutas respecto al resultado final.

RIESGOS Y COMPLICACIONES POSIBLES

Comprendo que pueden presentarse complicaciones inherentes al procedimiento, incluyendo:

- Dolor postoperatorio.
- Sensibilidad persistente.
- Inflamación.
- Persistencia de infección.
- Absceso dental.
- Aumento temporal de síntomas.
- Fístula.
- Fracaso del tratamiento.
- Necesidad de retratamiento.
- Necesidad de cirugía periapical.
- Necesidad de extracción dental.

COMPLICACIONES TÉCNICAS

Comprendo que debido a la anatomía interna del diente pueden presentarse:

- Conductos calcificados.
- Conductos estrechos.
- Conductos adicionales no identificados inicialmente.
- Conductos curvos.
- Escalones durante la instrumentación.
- Perforaciones.
- Transporte del conducto.
- Fractura de instrumentos endodónticos.
- Imposibilidad de instrumentar completamente algunos conductos.
- Necesidad de remisión a especialista en endodoncia.

RIESGOS RELACIONADOS CON LOS IRRIGANTES Y MEDICAMENTOS INTRACANALES

Comprendo que durante el procedimiento pueden utilizarse sustancias químicas desinfectantes y medicamentos intracanales que, aunque se emplean bajo protocolos clínicos establecidos, pueden ocasionar:

- Dolor.
- Irritación de tejidos blandos.
- Inflamación.
- Reacciones alérgicas poco frecuentes.
- Necesidad de tratamiento adicional.

NECESIDAD DE TRATAMIENTO DEFINITIVO

Comprendo que después de la pulpectomía generalmente será necesario:

- Completar tratamiento de conductos.
- Realizar restauración provisional.
- Realizar restauración definitiva.
- Colocar poste cuando esté indicado.
- Colocar corona cuando esté indicada.
- Realizar controles clínicos y radiográficos.

Entiendo que no completar estas fases puede ocasionar:

- Reinfeción del diente.
- Fractura dental.
- Persistencia de la lesión periapical.
- Fracaso del tratamiento.
- Pérdida del órgano dental.

RIESGOS RELACIONADOS CON LA ANESTESIA LOCAL

Comprendo que la anestesia local puede ocasionar:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| • Dolor en el sitio de punción. | • Parestesia temporal. |
| • Hematoma. | • Reacciones alérgicas. |
| • Inflamación. | • Palpitaciones transitorias. |
| • Trismus. | • Síncope vasovagal. |

- Mordeduras accidentales.

- Complicaciones médicas poco frecuentes.

SITUACIONES CLÍNICAS IMPREVISIBLES

Entiendo que durante el procedimiento pueden encontrarse condiciones no evidenciadas inicialmente tales como:

- Fracturas radiculares.
- Reabsorciones internas.
- Reabsorciones externas.
- Conductos accesorios.
- Calcificaciones severas.
- Perforaciones preexistentes.
- Defectos estructurales extensos.
- Pronóstico desfavorable del diente.

Autorizo al profesional para modificar razonablemente el plan de tratamiento cuando sea necesario para preservar mi salud oral.

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Se me ha informado que dependiendo del diagnóstico pueden existir alternativas como:

- Tratamiento endodóntico completo en una sola fase.
- Tratamiento farmacológico paliativo temporal.
- Retratamiento endodóntico.
- Cirugía periapical.
- Exodoncia.
- No realizar tratamiento, comprendiendo las consecuencias derivadas de dicha decisión.

INDICACIONES POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO

Comprendo que debo:

- Cumplir la medicación prescrita.
- Evitar masticar alimentos duros sobre el diente tratado.
- Mantener adecuada higiene oral.
- Asistir a los controles programados.
- Completar el tratamiento definitivo dentro del tiempo recomendado.
- Informar cualquier dolor intenso, inflamación progresiva o complicación.

DECLARACIÓN DEL PACIENTE

Declaro que he recibido explicación suficiente sobre el diagnóstico, el procedimiento de pulpectomía, sus beneficios, limitaciones, riesgos generales, riesgos específicos, posibles complicaciones y alternativas terapéuticas.

He tenido la oportunidad de realizar preguntas y todas han sido respondidas satisfactoriamente.

Comprendo que la pulpectomía puede constituir únicamente una fase inicial del tratamiento y que será necesario cumplir con las etapas posteriores indicadas para aumentar las probabilidades de éxito clínico.

Por lo anterior, autorizo libre y voluntariamente la realización de la pulpectomía descrita en este documento.

FIRMAS

PACIENTE O REPRESENTANTE LEGAL	ODONTÓLOGO TRATANTE	TESTIGO (OPCIONAL)
Nombre: _____ _____	Nombre: _____ _____	Nombre: _____ _____
Documento: _____ _____	Registro profesional: _____ _____	Documento: _____ _____
Firma: _____ _____	Firma: _____ _____	Firma: _____ _____
Fecha: ____ / ____ / ____	Fecha: ____ / ____ / ____	Fecha: ____ / ____ / ____

OBSERVACIONES